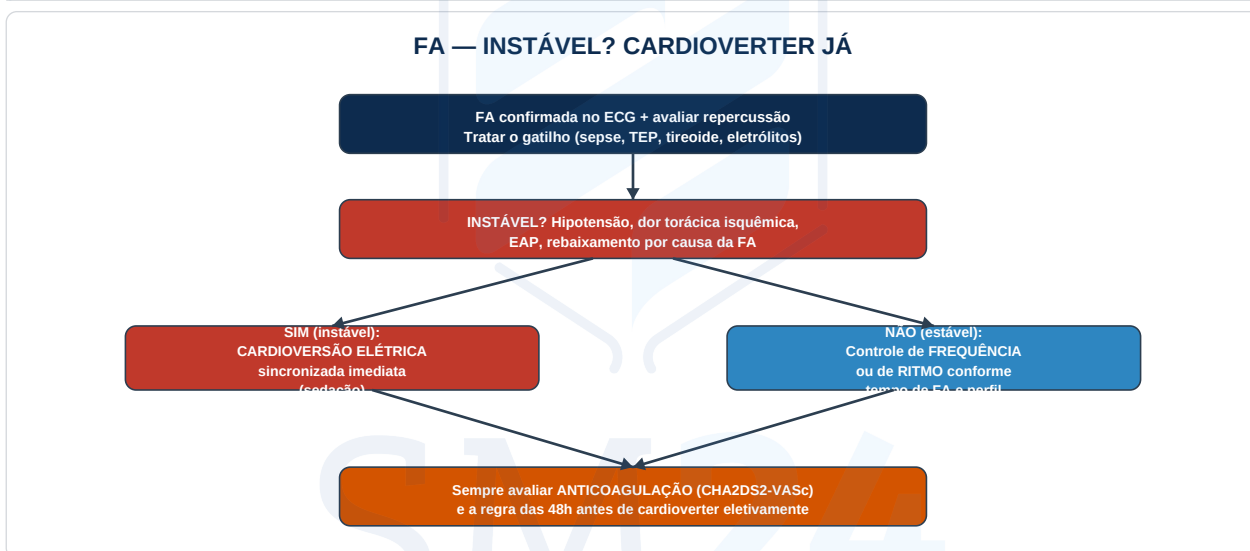


FA — ESTABILIDADE, RITMO/FREQUÊNCIA, ANTICOAGULAR

CLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO

Aspecto	Detalhe
ECG	Ritmo irregularmente irregular, ausência de onda P, ondas f, RR variável
Paroxística	Reverte espontaneamente ou em até 7 dias
Persistente	Dura > 7 dias ou exige cardioversão
Permanente	FA aceita, sem nova tentativa de reversão
FA de início recente	< 48h — janela que influencia a decisão de cardioversão
Gatilhos no PS	Sepse, TEP, hipertireoidismo, IAM, distúrbio eletrolítico, álcool (holiday heart), pós-operatório

ALGORITMO — FA NO PRONTO-SOCORRO



CONTROLE DE FREQUÊNCIA vs RITMO

Estratégia	Quando preferir	Drogas
Controle de FREQUÊNCIA	Idoso, FA crônica/assintomática, FC alta sem instabilidade	Betabloqueador OU BCC não-diidro (diltiazem/verapamil)
Controle de RITMO	FA recente (<48h), 1o episódio, jovem, muito sintomático	Cardioversão elétrica OU química (amiodarona, propafenona)
FA com IC / FEVE baixa	Evitar BCC não-diidro e propafenona	Betabloqueador com cautela; amiodarona; digoxina adjuvante
Meta de FC	FC < 110 bpm em repouso (controle leniente) na maioria	Titular a droga conforme resposta
Digoxina	Adjuvante em IC ou hipotensão (não reduz FC no esforço)	0,25 mg IV, repetir; início de ação lento

DOSES — CONTROLE DE FA

Rx FREQUÊNCIA, RITMO E CARDIOVERSÃO

Metoprolol (tartarato): 2,5-5 mg IV em 2 min, repetir até 15 mg — controle de FC
Diltiazem: 0,25 mg/kg IV em 2 min (cerca de 15-20 mg), repetir 0,35 mg/kg; manutenção 5-15 mg/h
Verapamil: 2,5-5 mg IV — evitar em IC/FEVE reduzida
Digoxina: 0,25 mg IV, repetir até 1-1,5 mg em 24h — adjuvante em IC/hipotensão
Amiodarona: 150 mg IV em 10 min + 1 mg/min por 6h — controle de FC e reversão; preferida em IC/instabilidade limítrofe
Propafenona (pill-in-the-pocket): 450-600 mg VO em FA recente sem cardiopatia estrutural
Cardioversão elétrica sincronizada: 120-200 J (bifásico) com sedação — 1a escolha no instável

ANTICOAGULAÇÃO E A REGRA DAS 48 HORAS

CARDIOVERSÃO TEM RISCO DE EMBOLIA

- CHA2DS2-VASc: anticoagular se ≥ 2 (homem) ou ≥ 3 (mulher); considerar se 1 (homem)/2 (mulher)
- FA < 48h: pode cardioverter; anticoagular conforme risco embólico após o procedimento
- FA ≥ 48 h ou tempo indeterminado: anticoagular por 3 semanas antes OU ecocardiograma transesofágico para excluir trombo antes de cardioverter
- Após cardioversão: anticoagular por pelo menos 4 semanas (atordoamento atrial = risco de trombo)
- DOAC (apixabana, rivaroxabana) são preferidos sobre varfarina na FA não valvar
- FA valvar (estenose mitral, prótese mecânica): varfarina
- Paciente instável: cardioverter imediatamente, mesmo sem anticoagulação prévia (risco de vida supera o embólico)

SITUAÇÕES ESPECIAIS

FA + Pré-excitação (WPW)

- ECG: FA com QRS largo, bizarro e muito rápido (irregular)
- EVITAR bloqueadores do nó AV: betabloqueador, BCC, digoxina e adenosina
- Esses fármacos favorecem condução pela via acessória -> FV
- Tratamento: cardioversão elétrica se instável
- Estável: procainamida ou amiodarona (com cautela)
- Encaminhar para ablação da via acessória

FA Secundária / Reversível

- Tratar a causa de base muitas vezes reverte a FA
- Sepse, TEP, IAM, hipertireoidismo, distúrbio eletrolítico (K^+ , Mg^{++})
- Repor potássio e magnésio (alvo $K^+ > 4$, $Mg > 2$)
- Holiday heart: FA após liberação alcoólica em jovem sem cardiopatia
- Pós-operatório: controle de FC + corrigir distúrbios
- Evitar cardioversão de FA crônica disfarçada de aguda sem anticoagulação

CONDUTA E ALTA

FECHAMENTO DO CASO

- ☐ ECG de 12 derivações + monitorização; tratar gatilho reversível
- ☐ Decidir ritmo vs frequência pelo tempo de FA, sintomas e cardiopatia
- ☐ Instável: cardioversão elétrica sincronizada imediata
- ☐ Calcular CHA2DS2-VASc e HAS-BLED; iniciar anticoagulação quando indicado
- ☐ Respeitar a regra das 48h antes de cardioversão eletiva (ou ECO transesofágico)
- ☐ Alta: anticoagulação definida, controle de FC, encaminhar à cardiologia e investigar etiologia

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com FA de alta resposta ventricular, PA 70/40, dor torácica e rebaixamento. Qual a conduta imediata?

- A) Metoprolol IV para controle de frequência
- B) Cardioversão elétrica sincronizada imediata com sedação
- C) Amiodarona em bomba de infusão por 24h
- D) Digoxina IV e observação
- E) Adenosina 6 mg IV

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente estável com FA de início há 5 dias, CHA2DS2-VASc 4, deseja-se cardioverter. Qual a conduta correta quanto à anticoagulação?

- A) Cardioverter imediatamente sem anticoagulação
- B) Anticoagular por 3 semanas antes (ou ECO transesofágico excluindo trombo) e manter por pelo menos 4 semanas após
- C) Cardioverter e anticoagular apenas se houver embolia
- D) Apenas AAS antes do procedimento
- E) Heparina em bolus único no momento da cardioversão é suficiente

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente jovem com FA, QRS largo, muito rápido e irregular, com padrão de pré-excitação (WPW). Qual fármaco deve ser EVITADO?

- A) Procainamida
- B) Amiodarona
- C) Cardioversão elétrica
- D) Diltiazem (bloqueador do nó AV)
- E) Sedação para cardioversão

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Idoso de 80 anos com FA permanente, assintomático, FC 95 bpm em repouso. Qual a melhor estratégia?

- A) Cardioversão elétrica eletiva
- B) Controle de frequência (betabloqueador ou BCC) com meta de FC < 110 bpm
- C) Amiodarona para reverter ao ritmo sinusal
- D) Propafenona pill-in-the-pocket
- E) Ablação imediata

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com FA aguda e fração de ejeção reduzida (IC). Qual droga de controle de frequência deve ser EVITADA?

- A) Verapamil ou diltiazem (BCC não-diidropiridínicos)
- B) Betabloqueador
- C) Digoxina
- D) Amiodarona
- E) Sulfato de magnésio

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

FA com instabilidade (hipotensão, dor torácica isquêmica, EAP ou rebaixamento atribuíveis à arritmia) exige cardioversão elétrica sincronizada imediata, sob sedação. Drogas de controle de frequência ou ritmo são para o paciente estável.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

FA $\geq$ 48h (aqui 5 dias) com desejo de cardioversão: anticoagular por 3 semanas antes OU realizar ECO transesofágico para excluir trombo atrial, e manter anticoagulação por pelo menos 4 semanas após (atordoamento atrial pós-cardioversão favorece trombo). CHA2DS2-VASc 4 também indica anticoagulação de longo prazo.

QUESTÃO 3 → Resposta: D

Na FA pré-excitada (WPW), os bloqueadores do nó AV (betabloqueador, BCC como diltiazem/verapamil, digoxina e adenosina) são contraindicados: favorecem a condução pela via acessória, podendo degenerar em fibrilação ventricular. Usar cardioversão (instável) ou procainamida/amiodarona (estável).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Idoso com FA permanente assintomático: a estratégia de controle de frequência é preferida, com meta leniente de FC < 110 bpm em repouso (betabloqueador ou BCC não-diídrico). Controle de ritmo não traz benefício nesse perfil e expõe a riscos.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Na FA com IC e FEVE reduzida, os BCC não-diidropirídínicos (verapamil, diltiazem) devem ser evitados pelo efeito inotrópico negativo, que pode descompensar a IC. Preferir betabloqueador (com cautela), digoxina (adjuvante) ou amiodarona.

SM24
Suporte ao Plantão Médico